

胰臟癌早期有哪些症狀？

6 大警訊別錯過

章醫師 | 胰臟健康部落格 | 2026 | 閱讀約 6 分鐘

摘要 • SUMMARY

胰臟是沉默的器官，胰臟癌早期常常沒有明顯症狀，卻會用一些容易被忽略的小變化提醒我們。本文整理出胰臟癌最值得警覺的 6 大警訊：不明原因暴瘦、新發糖尿病、頑固脹氣、油便、上腹連背痛與黃疸，並提醒你別被正常的 CA19-9 誤導，以及為什麼 MRI 是早期篩檢的首選。花幾分鐘讀完，也許就能為自己或家人多爭取一次早期發現的機會。

胰臟癌早期到底有沒有症狀？如果有，是哪些？又該怎麼分辨這些訊號是單純「消化不良」，還是「胰臟在求救」？這篇文章，我把最值得警覺的六個警訊整理出來，一次講清楚。

不過在講警訊之前，得先說一句最反直覺、卻最重要的話——

早期胰臟癌最多的症狀，就是沒症狀。

一 為什麼大家容易誤解？

最大的誤解，是以為胰臟疾病「離我很遠」。很多人覺得胰臟病發生率低、跟自己無關，也不知道原來胰臟癌是可以提早篩檢的。

第二個誤解，是把早期症狀當成小毛病。胰臟剛出狀況時，最常見的表現就是消化不良、脹氣、悶悶的不舒服——這些和一般腸胃問題太像了，很容易被自己、甚至被醫師忽略過去。

第三個誤解，是太依賴抽血的「胰臟癌指數」CA19-9。其實第一期胰臟癌的病人，CA19-9 幾乎都在正常範圍；人群中還有約一到一成五的人天生不會產生 CA19-9，就算到了第四期，指數也永遠正常。**所以指數正常，絕不等於沒事。**

二 章醫師怎麼思考？

我看診時，不會只盯著單一數字，而是把身體的變化「連起來看」。當一個人同時出現體重莫名下降、血糖突然亂掉、排便變油，我腦中的警鈴就會響起——這往往不是巧合，而是**胰臟正在同時失去消化和控糖兩種功能**。以下是我最在意的六大警訊，只要出現其中一項，都值得認真檢查胰臟：

①

不明原因的體重減輕

沒有刻意節食，卻一路暴瘦。

②

突然出現的糖尿病

或原本穩定的血糖突然控制不住。

③

頑固的長期脹氣

吃一般消脹氣藥也壓不下來的消化不良。

④

排便改變

次數增加、大便不成型，或出現浮油的油便。

⑤

上腹悶痛

甚至會往後背延伸的疼痛。

⑥

黃疸

皮膚或眼白變黃、尿液變深、大便變淺。

三 新醫學證據

醫學上已經確認，「**新發生的糖尿病**」是**胰臟癌的重要線索**。研究發現，不少胰臟癌病人在確診前的兩到三年，血糖就已經悄悄開始上升。特別是五十歲以後、沒有家族糖尿病史卻突然得糖尿病的人，更要提高警覺。

在檢查工具上，目前國際上最推薦用來篩檢早期胰臟癌的是核磁共振（MRI／MRCP）。它沒有輻射、解析度高，有機會找出最小的腫瘤和最早期的變化；必要時再搭配內視鏡超音波，把探頭直接帶到胃和十二指腸旁近距離觀察，準確度更高。

四 臨床經驗分享

在長期追蹤大量病人之後，我發現一件很重要的事：胰臟出問題，常常不只一個原因。我們針對每位病人地毯式調查，發現**高達三到五成的人是「多重原因」造成**。所以我從不會找到一個理由就滿意，因為漏掉任何一個，都可能錯過一次治療的機會。

我也常提醒病人，在家就能做兩件簡單的自我觀察：一是每一到三個月量一次體重，二是留意排便有沒有變油、變軟。這兩個小習慣，就是最平價又最實用的胰臟守門員。

— 重點整理

- ① 胰臟是「沉默器官」，早期症狀極不明顯，別等到會痛才檢查。
- ② 六大警訊：暴瘦、新發糖尿病、頑固脹氣、油便、上腹連背痛、黃疸。
- ③ 五十歲後突然得糖尿病、血糖莫名變亂，務必回頭檢查胰臟。
- ④ CA19-9 正常不代表沒事，第一期胰臟癌指數多半是正常的。
- ⑤ MRI 是目前篩檢早期胰臟癌最推薦的工具。

五 結語

胰臟不會大聲喊痛，但它會用一點一滴的小改變偷偷提醒你。學會聽懂這些訊號，及早檢查，就是給自己和家人最好的一份保險。

常見問題 FAQ

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q1. 胰臟癌早期一定會痛嗎？

A 不一定。胰臟是沉默器官，早期常常完全不痛，更多是暴瘦、脹氣、油便或血糖異常等不明顯的變化，所以更需要靠警訊主動察覺。

Q2. 突然得糖尿病，會是胰臟癌嗎？

A 不一定，但值得檢查。特別是五十歲後、沒有家族史卻突然血糖飆高，或原本穩定的糖尿病突然失控，建議進一步安排胰臟檢查。

Q3. CA19-9 正常就代表沒有胰臟癌嗎？

A 不能這樣說。第一期胰臟癌的 CA19-9 多半正常，也有人天生不會產生 CA19-9，指數正常並不能排除胰臟癌。

Q4. 什麼是油便？和胰臟有什麼關係？

A 油便是糞便浮油、黏马桶、沖不太掉，代表脂肪沒被消化。這往往是胰臟消化酶明顯不足的訊號，胰臟功能可能已剩下不到 15%。

Q5. 想篩檢早期胰臟癌，該做什麼檢查？

A 目前國際上最推薦的是核磁共振（MRI／MRCP），沒有輻射且能看到最早期的變化；必要時再搭配內視鏡超音波進一步確認。

Q6. 哪些人屬於胰臟癌高危險群？

A 年齡 50 歲以上、突然出現或惡化的糖尿病、有胰臟癌家族史、長期抽菸喝酒、慢性胰臟炎，以及不明原因暴瘦的人，都建議提高警覺。

下一步 • NEXT STEP

**六大警訊中了任何一項，
就別再當成消化不良——及早檢查胰臟。**

暴瘦、新發糖尿病、油便、上腹連背痛或黃疸者，建議安排胰臟檢查。檢查與篩檢計畫，請與您的胰臟專科醫師討論。

預約胰臟檢查諮詢

← 上一篇

骨質疏鬆與維生素 D 缺乏：居然與你的「胰臟功能」息息相關？

下一篇 →

誰需要特別注意胰臟健康？兩分鐘自我檢視